

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 7 — Césarienne : préparation

Périmètre limité — installment 3/n : ce document source compte 15 « Questions » cliniques et 369 citations de grade au total. Cette fiche couvre INTÉGRALEMENT la Question 7 (blocs périmédullaires pour la césarienne). La Question 6 (travail obstétrical) est EXCLUE — superseded par une fiche séparée plus récente (HAS 2025, « Douleur de l'accouchement »). Les Questions 1-2 et 3-5 sont couvertes par des fiches séparées. Les Questions 8 à 15 (analgésie postopératoire périmédullaire générale, terrains spécifiques, échec, facteurs de risque) ne sont PAS couvertes ici — installments futurs.

Grille EBM classique — **A** : essais randomisés de forte puissance/méta-analyses ; **B** : essais randomisés de faible puissance/études de cohorte ; **C** : cas-témoins/études rétrospectives ; **D** : cité par le source mais JAMAIS défini dans son propre préambule méthodologique (incohérence du source, disclosed, non assimilée à C) ; **AE** : accord professionnel — regroupe aussi « consensus professionnel ». Fiche limitée à la Question 7/15.

A	B	C	D	AE
---	---	---	---	----

Question 7 — Blocs périmédullaires pour la césarienne : préparation

Catégorie	Recommandation	Grade
Jeûne	Avant une césarienne programmée, un jeûne de 6-8h concernant les solides est recommandé ; considérer la parturiente comme à risque d'inhalation du contenu gastrique du fait des modifications physiologiques de la grossesse (risque surtout présent au cours du travail).	C
Prévention inhalation	L'administration systématique d'agents anti-H2 (cimétidine ou ranitidine) combinés à du citrate de sodium (forme effervescente) est recommandée avant la césarienne.	C
Surveillance fœtale	En chirurgie programmée, un enregistrement du RCF est réalisé en préopératoire ; le matériel d'évaluation du RCF doit être disponible à l'arrivée en salle (avec un membre de l'équipe obstétricale pour l'interpréter), pour guider le choix de la technique anesthésique selon le délai disponible.	C
Surveillance maternelle	Surveillance toutes les minutes lors de l'induction de la rachianesthésie pour césarienne, puis toutes les 2-3 minutes en phase de stabilité ; mesures plus fréquentes en cas de médicaments vasoactifs (dont ocytocine), d'hémorragie ou de tout incident (nausées, vomissements).	D
Décubitus	Un décubitus latéral gauche d'au moins 10° est recommandé jusqu'à l'extraction fœtale (lève partiellement la compression aortocave, contrairement au décubitus complet).	C
Oxygénothérapie	L'intérêt de l'administration d'oxygène est documenté dans les situations maternelles ou fœtales pathologiques.	C
Qualité du bloc	Associer systématiquement un morphinique liposoluble à l'AL utilisé, pour améliorer la qualité de l'APM pour la césarienne.	A
Qualité du bloc	Contrôler qu'un niveau adéquat d'anesthésie est atteint avant l'incision — utiliser la perte de perception du toucher léger/de la stimulation douloureuse (et non le chaud-froid ni le piquer-toucher, non adaptés) ; test prédictif fiable si le niveau atteint au moins T5.	C

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 7 — Choix technique & échec



Choix de la technique et des agents

Catégorie	Recommandation	Grade
Choix technique	L'ALR périmédullaire doit être privilégiée chaque fois que possible pour la césarienne, tout particulièrement en situation non programmée ; seules les césariennes en extrême urgence (délai décision-extraction < 5-10 min) et les contre-indications à l'APM doivent indiquer une AG.	C
Rachianesthésie	Technique de choix pour les césariennes programmées.	C
Rachianesthésie	Les aiguilles pointe-crayon doivent être utilisées systématiquement en obstétrique, avec un diamètre $\leq 25G$.	A
Rachianesthésie	L'adjonction d'un morphinique liposoluble (fentanyl ou sufentanil) est recommandée — améliore la qualité de la rachianesthésie et permet de réduire la dose d'AL ; dose de fentanyl intrathécal $\approx 10 \mu g$, sufentanil 2,5-5 μg .	B
Rachianesthésie	Dose de bupivacaine recommandée $\approx 10 mg$ pour un taux de réussite proche de 100 %.	B
Rachianesthésie	La forme hyperbare est la plus couramment utilisée, mais la forme isobare donne une anesthésie similaire et constitue une alternative possible.	C
Rachianesthésie	La dose de ropivacaine intrathécale efficace doit être majorée de 50 % ($\approx 15 mg$) par rapport à la bupivacaine pour un effet équivalent.	C
Rachianesthésie	Morphine intrathécale 100 μg pour l'analgésie postopératoire (n'améliore que partiellement la qualité peropératoire — associer un morphinique liposoluble à l'AL reste recommandé).	C
Péridurale	Injection de 15-20 ml de lidocaïne 2 % adrénalinée (1:200 000) pour atteindre un niveau d'anesthésie chirurgicale en 10 minutes dans la plupart des situations, évitant le recours à une AG.	C
Péridurale	Addition d'un morphinique liposoluble en bolus recommandée, surtout s'il n'a pas été utilisé pendant le travail.	C
Péridurale	Une rachianesthésie supplémentaire pour renforcer une péridurale déjà en place ou insuffisante n'est pas recommandée (risque important de rachianesthésie extensive).	C
RPS	La rachianesthésie-péridurale séquentielle peut être utilisée de deux façons : dose intrathécale complète avec recours possible au cathéter péridural pour une difficulté prévisible, ou petite dose intrathécale + complément péridural d'emblée (titration, effets hémodynamiques moindres — objectif prioritaire) ; fractionner la dose du cathéter péridural d'une RPS non préalablement utilisé pendant le travail.	C

Gestion de l'échec / des imperfections

Catégorie	Recommandation	Grade
Échec — rachianesthésie	En cas d'extension insuffisante, attendre quelques minutes (Trendelenburg modéré $\leq 10^\circ$ si solution hyperbare) ; en cas d'échec du bloc, convertir en AG sans attendre l'incision.	C
Échec — péridurale/RPS	Réinjecter un AL d'action rapide (lidocaïne 2 % adrénalinée ou ropivacaine 0,75 %) $\pm$ morphinique liposoluble ; en cas d'échec de ces compléments ou si le délai d'extraction est urgent, recourir à l'AG.	C

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 7 — Choix technique & échec

**Fig. 1 (source, transcription textuelle du diagramme) — Place de l'ALR dans la césarienne :**

Non programmée → (voie principale) cathéter péridural en place → souffrance fœtale aiguë : évaluer le degré d'urgence et le risque anesthésique maternel/fœtal → utilisation du cathéter (majoritaire) ou AG (minoritaire, urgence extrême) ; pas de souffrance fœtale → utilisation du cathéter. (voie minoritaire) pas de cathéter péridural → urgence immédiate → AG (majoritaire) ou rachianesthésie ± péridurale selon urgence/état fœtal (minoritaire) ; urgence différable → rachianesthésie ± péridurale selon degré d'urgence et état fœtal.

Programmée → (voie principale) pas de contre-indication à l'ALR → césarienne techniquement simple → rachianesthésie seule ; césarienne potentiellement longue, enfant ou mère fragile, nécessité de contrôler le niveau → rachi-péri combinée (ou péridurale). (voie minoritaire) contre-indication à l'ALR → anesthésie générale.

NB du source : cet algorithme doit aussi prendre en compte l'organisation de la structure (locaux, astreinte ou garde sur place...) et l'expérience des intervenants ; l'épaisseur des flèches du diagramme original traduit la fréquence des différentes situations.

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 7 — Situations particulières, analgésie postop & sources



Situations obstétricales particulières

Repères non gradés : l'ALR périmédullaire peut être contre-indiquée en cas de troubles de la coagulation induits par la pathologie obstétricale (ex. hématome rétroplacentaire) ou un traitement concomitant (ex. anticoagulant efficace) — mais l'APM garde de nombreux avantages sur l'AG et peut être réalisable devant des contre-indications classiquement relatives (analyse bénéfice/risque, à noter au dossier).

Catégorie	Recommandation	Grade
Prééclampsie/éclampsie	Il est licite d'utiliser la rachianesthésie ou la RPS en cas de prééclampsie même sévère — paradoxalement, moins d'hypotension et moindre besoin en éphédrine sont rapportés chez ces patientes (pas de données sur la phényléphrine dans cette population). La péridurale reste une alternative.	C
Éclampsie	L'existence d'une hypertension intracrânienne patente et/ou de signes de localisation demeure une contre-indication incontournable à l'ALR.	AE
Anomalies placentaires	L'anesthésie périmédullaire est souhaitable lorsque le placenta est postérieur ou latéral, même si un saignement minime ou modéré est en cours.	C
Anomalies placentaires	En cas de placenta antérieur sur utérus cicatriciel, de saignement actif en cours, ou d'imagerie évoquant un placenta accreta, l'anesthésie générale est recommandée.	C

Analgésie postopératoire de la césarienne sous ALR périmédullaire

Repères non gradés : l'analgésie postopératoire après césarienne est multimodale, la voie périmédullaire en étant l'une des composantes. Chez les patientes obèses, les morphiniques (périmédullaires ou systémiques) justifient une surveillance dans une structure adaptée. La clonidine (péridurale ou intrathécale) augmente la qualité/durée de l'analgésie mais induit une sédation (action courte, 4h, par voie péridurale) — son utilisation n'est donc pas recommandée.

Catégorie	Recommandation	Grade
Voie périmédullaire	Supérieure à la voie systémique pour la qualité de l'analgésie et la moindre sédation, lorsqu'elle est utilisée en monothérapie.	A
Sécurité	Le risque de dépression respiratoire est documenté pour la morphine à des doses > 250 µg par voie intrathécale ou > 3 mg par voie péridurale — l'association de morphiniques par plusieurs voies impose une surveillance renforcée.	B
Dose péridurale	Dose optimale de morphine péridurale en bolus : 3-3,75 mg en monothérapie (risque accru de dépression respiratoire au-delà).	B
Dose péridurale	Une efficacité équivalente peut être obtenue avec 1-2 mg de morphine péridurale lorsqu'un AINS est associé par voie systémique.	B
Dose intrathécale	Pas de bénéfice à utiliser une dose de morphine intrathécale supérieure à 80-100 µg sans conservateur (effets secondaires majorés au-delà).	A

Sources et avertissement

Document source : SFAR/Sofcot/Sofmer, « Les blocs périmédullaires chez l'adulte », Recommandations pour la Pratique Clinique, présentées le 24 septembre 2005 (47e congrès SFAR), Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 26 (2007) 720-752.

URL source : <https://sfar.org/les-blocs-perimedullaires-chez-ladulte/>

Couverture : Question 7/15 uniquement (césarienne) — 31 recommandations gradées (A:4, B:5, C:20, D:1, AE:1). La Question 6 (travail obstétrical) est EXCLUE — superseded par une fiche séparée plus récente (HAS 2025). Les Questions 1-2 et 3-5 sont couvertes par des fiches séparées. Les Questions 8 à 15 ne sont pas couvertes ici — hors périmètre, installments futurs. Argumentaire scientifique détaillé (document source complet) non reproduit.

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante et PARTIELLE (Question 7 uniquement, sur 15). Elle ne remplace pas le texte intégral — en particulier pour le travail obstétrical (voir la fiche HAS 2025 dédiée), l'analgésie postopératoire générale, ou tout terrain spécifique. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la SFAR.